Université Paris Cité

PASS UE 7
Cours 1 : De la recherche à la commercialisation du médicament : enjeux éthiques et sociaux (suite et fin).

Solène Lellinger
08/09/2026

Toute reproduction partielle ou totale du contenu de ce document sans accord de l'auteur est passible de poursuites.

II. L'innovation en question

A. Les essais cliniques et la médecine des preuves

B. Le tournant des années 1970 et les critiques de l'innovation

C. Les scandales sanitaires comme moteur de réformes

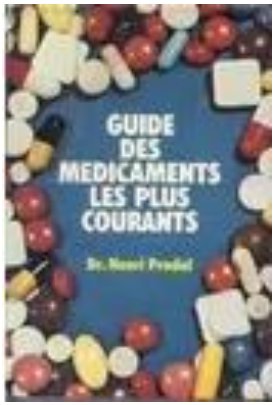
II. L'innovation en question / B. Le tournant des années 1970 et les critiques de l'innovation (1)

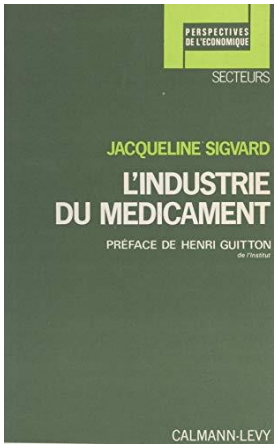
Fin années 1960/ début années 1970 : vague de **contestation** vis-à-vis des médicaments.

- Emergence d'un discours critique vis-à-vis du médicament et des stratégies des laboratoires pharmaceutiques
- Pour la première fois les entreprises pharmaceutiques sont l'objet **d'attaques et de critiques** de la part de l'opinion publique et de certains partis politiques.
- **Accusations** : contribuer aux difficultés de la sécurité sociale, de réaliser des profits éhontés, de creuser le déficit commercial de la France, de tromper les gens sur la valeur thérapeutique des produits, d'aliéné les malades.
- En 1974, de docteur Henri Pradal publie le *Guide des médicaments les plus courants* : Premier ouvrage grand public
- **Défenseurs de l'industrie pharmaceutique** (médecins, souvent inséré institutionnellement, des industriels, de syndicats de l'industries) = utilisent une terminologie axée sur le progrès, l'innovation, les prouesses de l'industrie, la technicité des équipements ainsi que les bénéfices pour la société (recul de certaines maladies autre fois mortelles pour arguer de l'utilité de l'industrie pharmaceutique.

Crise à la fin des années 70 est davantage morale et politique qu'économique.

=> Politisation croissante du médicament et de la santé et dans une moindre mesure du développement des mouvements contestataires au sein de la société française. Cette critique s'articule avec une baisse de l'innovation durant cette période.





II. L'innovation en question

A. Les essais cliniques et la médecine des preuves
B. Le tournant des années 1970 et les critiques de l'innovation
C. Les scandales sanitaires comme moteur de réformes

II. L'innovation en question/ C. Les scandales sanitaires comme moteur de réformes (1)

Scandales = révélateurs de dysfonctionnements et insuffisances de la régulation (prochain cours : ex Mediator détaillé)







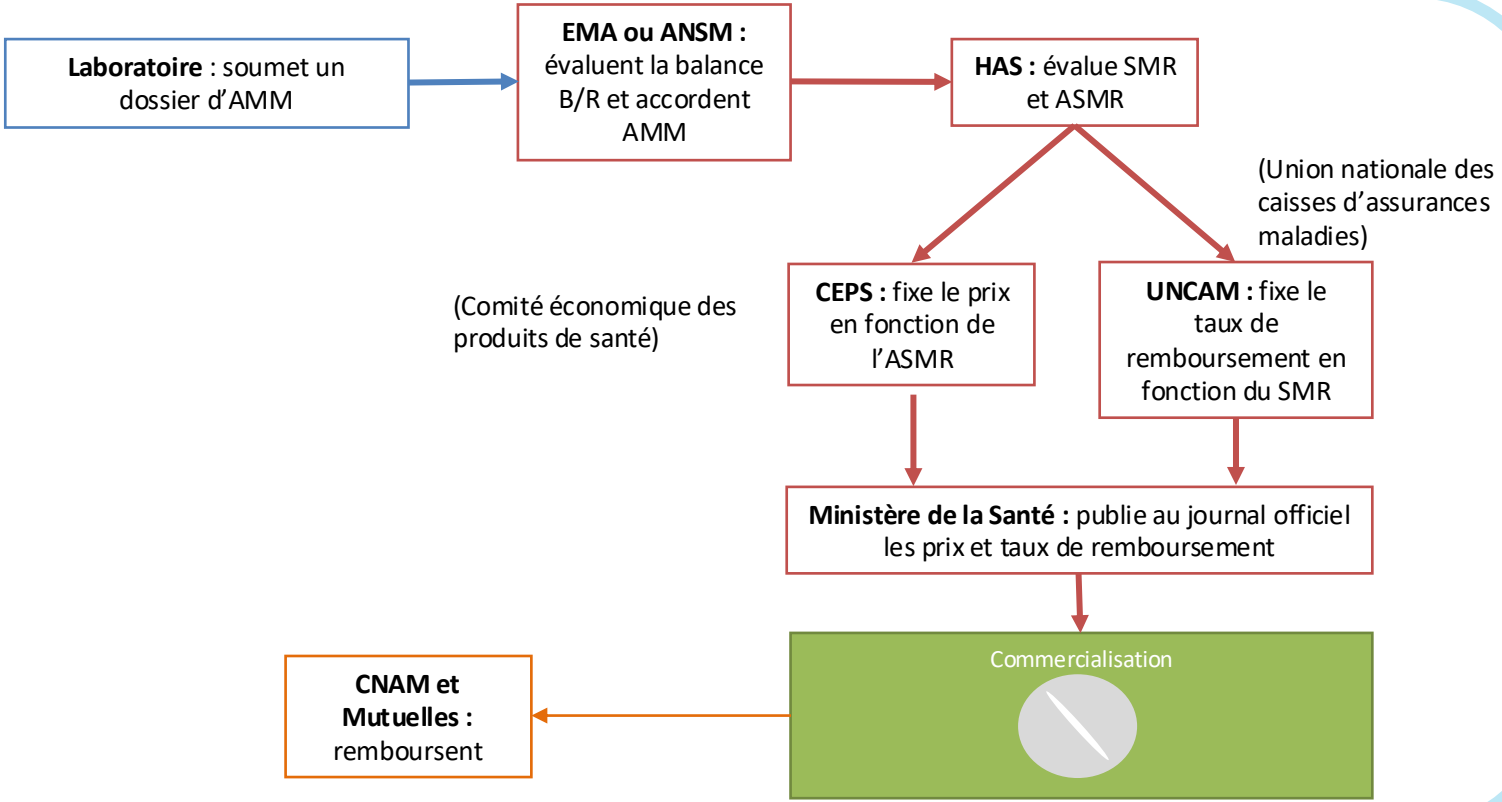


III. Les enjeux économiques du médicament

SMR Service médial rendu	ASMR Amélioration du service médial rendu
• **utilité absolue** d'un médicament • Guide la fixation du taux de remboursement	• **innovation relative** par rapport aux traitements existants • Permet de négocier le prix

Ne pas apprendre par cœurs les différentes instances : retenir que les différents éléments dépendent de différentes instances

III. Les enjeux économiques du médicament



III. Les enjeux économiques du médicament

↓ **A retenir** : Pour l'industriel, le taux de remboursement et la fixation du prix sont très important !

- Pour le remboursement : ça vaut dire que c'est payé par la sécurité sociale et moins c'est remboursé, moins il a de chance d'être prescrit car c'est le patient qui devrait payer !
- Pour la fixation du prix : c'est ce qu'il va toucher par boîte. Sans remboursement : le prix est libre

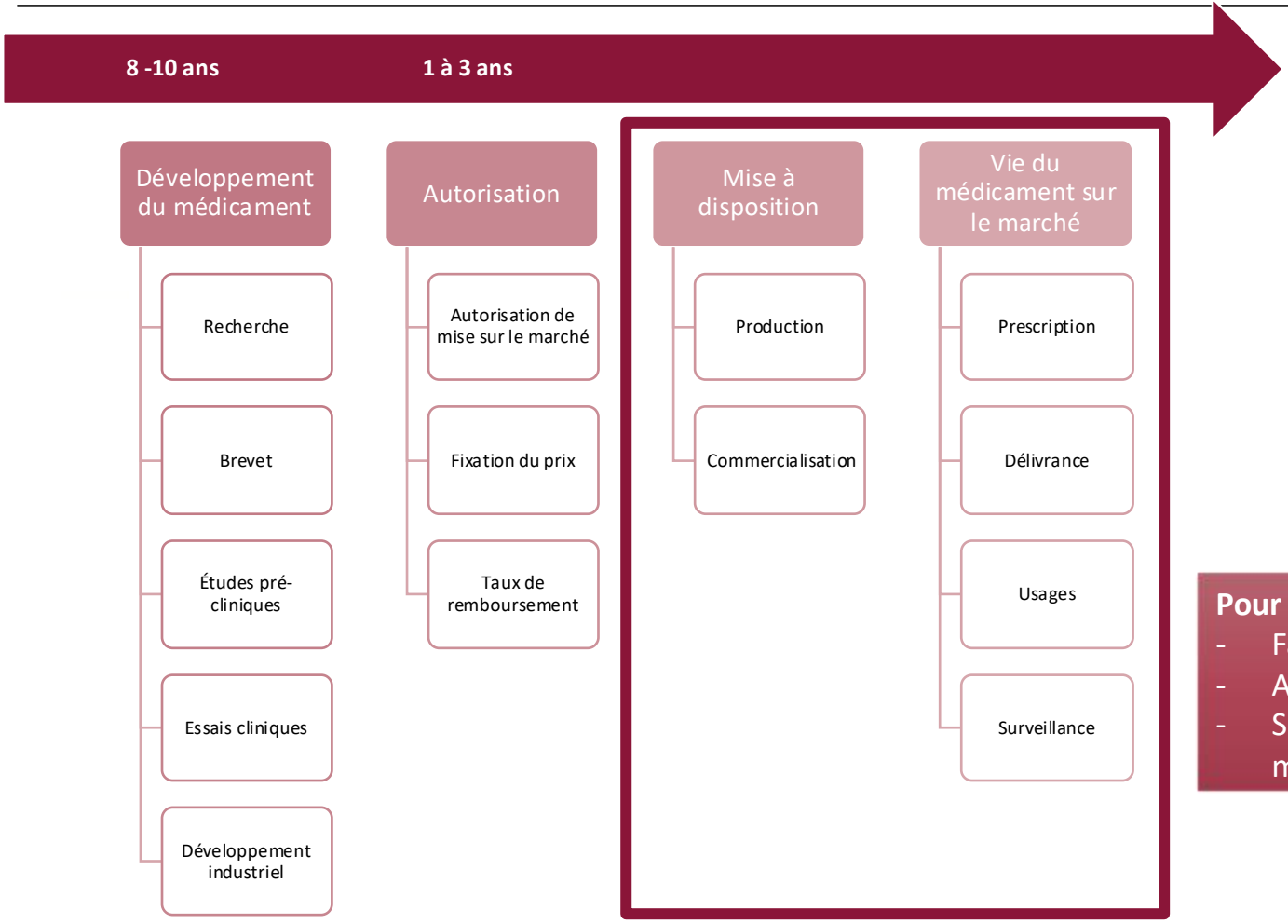
=> Les deux éléments sont liés et d'eux vont dépendre les recettes du laboratoire

Université Paris Cité

PASS UE 7
Cours 3 : De la prescription aux usages des médicaments : enjeux éthiques et sociaux

Solène Lellinger
08/09/2026

Toute reproduction partielle ou totale du contenu de ce document sans accord de l'auteur est passible de poursuites.



Pour l'industriel :

- Faire connaître sa molécule
- Assurer l'approvisionnement
- Surveiller son produit sur le marché

Introduction (2)



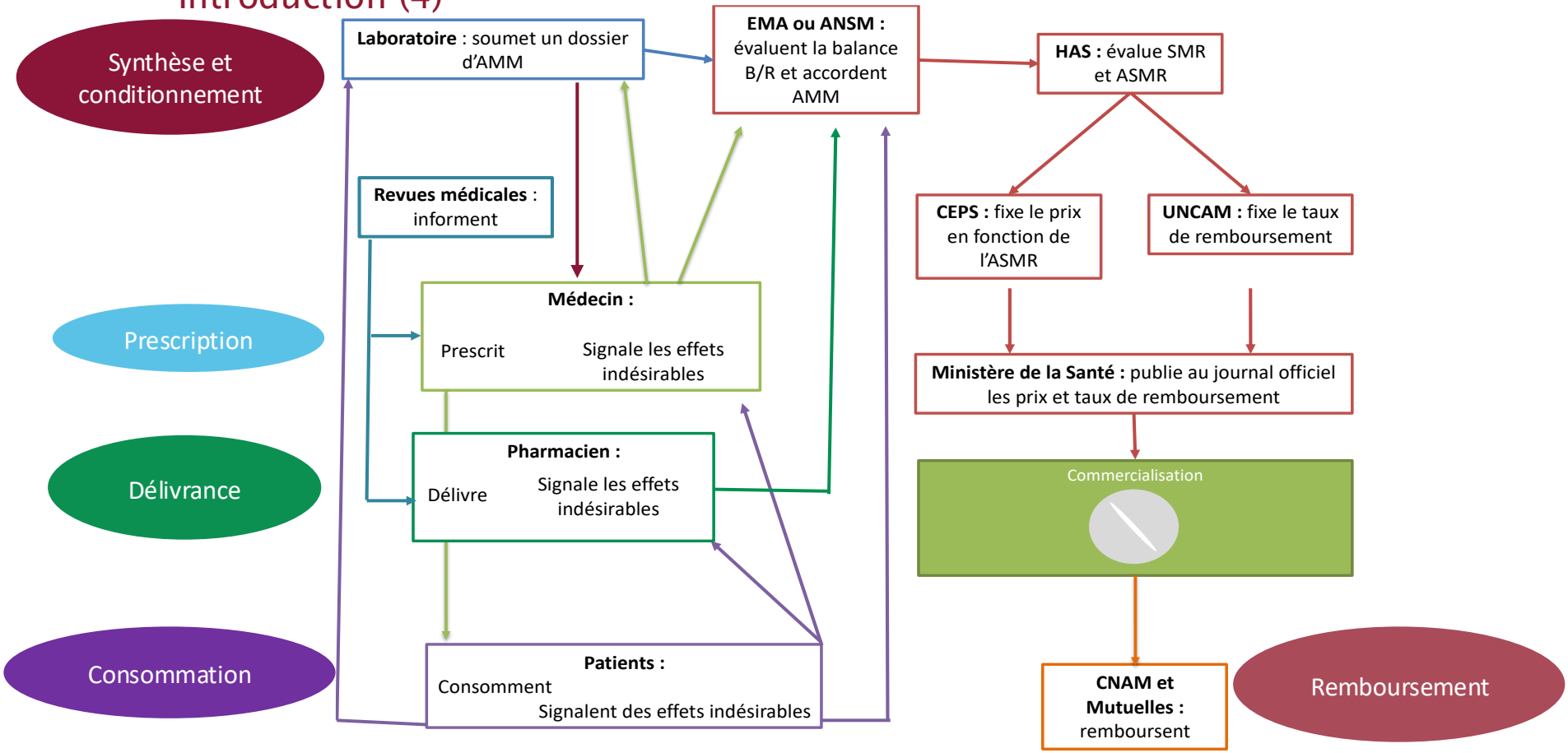
Plan général (détaillé dans les diapos suivantes)

I. Faire prescrire une nouvelle molécule
II. Délivrance et usages des médicaments
III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®

Objectifs :

- L'objectif de cette séance est de saisir les enjeux commerciaux et de vie réelle du médicament

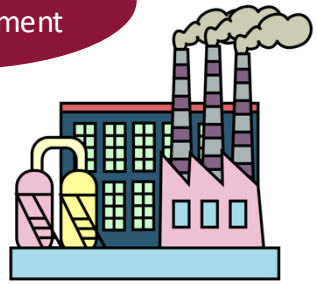
Introduction (4)



Prescription



Synthèse et conditionnement





Délivrance



Remboursement

l'Assurance Maladie



Consommation

I. Faire prescrire une nouvelle molécule

A. La publicité

B. La visite médicale

C. La demande des patients

I. Faire prescrire une molécule / A. La publicité

- Depuis l'essor des spécialités au XIXe : développement de stratégies commerciales destinées à augmenter les ventes de médicaments.
- On peut distinguer 4 périodes depuis l'avènement de l'industrie à la fin du 19e siècle, chacune étant marquée par un instrument commercial phare :
  - Entre la dernière moitié du 19e siècle et la Première Guerre mondiale : **annonces et affiches**.
  - Depuis les années 1900 : envois de **brochures** publicitaires non-sollicitées aux médecins, complété dans les années 1920 par envois d'**échantillons** de produits sur demande.
  - Les années 1940 : nouvel « instrument » du marketing des firmes, le **visiteur médical**. Ces représentants des firmes ont vu leur importance décliner depuis les années 1990.
  - Depuis : multiplication des **mécénats** des firmes auprès d'associations de patients, et une nouvelle concentration sur les patients consommateurs qui s'ajoute aux stratégies traditionnelles du marketing pharmaceutique.



1903

I. Faire prescrire une nouvelle molécule

A. La publicité

B. La visite médicale

C. La demande des patients

I. Faire prescrire une molécule / B. La visite médicale(1)



- Visiteurs médicaux : représentants commerciaux
- Loi 1941: pas de publicité à destination des usagers pour les médicaments soumis à prescription.

Thèse du sociologue Jérôme Greffion (2014) : étude de cette stratégie de promotion du médicament :

- Grandes entreprises qui domine le secteur pharmaceutique : services de promotion et de marketing très importants (30 à 40 % des effectifs).
- Dépenses de vente et de promotion > coûts de fabrication (1/4 chiffre d'affaires).
- « Visiteurs médicaux », « prospectent » des territoires et « démarchent » les médecins .
- Officiellement : salariés chargés de présenter les « spécialités pharmaceutiques afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical » : ils doivent « exposer les propriétés thérapeutiques », « mettre en valeur les composants », « faire ressortir les avantages et les indications » et « détailler les présentations, les contre-indications et la posologie ».
- En France 2014, les 16 000 visiteurs médicaux représentent un peu plus de 15 % des effectifs de l'industrie pharmaceutique, (1 visiteur médical pour 10 médecins enregistrés à l'Ordre des médecins). 2018 : moins de 10 000

I. Faire prescrire une molécule / B. La visite médicale(2)

- Pour J.Greffion : **Inversion des rapports de pouvoir possibles** : les médecins exercent une profession visible, respectée et puissante. « De leur côté, les visiteurs médicaux, même s'ils appartiennent à une industrie florissante, ont, comme tous les représentants de commerce, une image peu valorisée. De plus, ils occupent une position dominée dans leur entreprise, au bas de la hiérarchie commerciale, exécutant des stratégies marketing conçues pour eux. ».
- Relation visiteurs médicaux/médecins : « relation de démarchage d'un professionnel dominant », dont l'objet premier est immatériel : les dispositions du médecin en matière de prescription.

→ **Faire augmenter le volume de prescription des médicament**s présentés, volume que l'on peut mesurer par les données sur les ventes des pharmacies dans un périmètre donné.

I. Faire prescrire une molécule / B. La visite médicale(3)

- Ces dernières années : perte d'importance des visiteurs médicaux comme « outils » de la communication des entreprises
- Essor du recours au experts médicaux rémunérés par les entreprises de façon direct ou indirecte : « *key opinion leaders* » ou « guides de l'opinion » (médicale) :
  - Mettent leur renommée scientifique et leur réputation médicale au service d'une entreprise en plaidant pour telle ou telle thérapie médicamenteuse.
  - En contrepartie ces experts reçoivent des avantages matériels pour mener à bien leur recherche ou bénéficient, eux aussi, de la visibilité que leur offre l'entreprise (Sismondo 2013).
- Depuis environ vingt ans : critiques d'une proximité trop étroite entre la médecine d'un côté, et de l'industrie pharmaceutique de l'autre, ont gagné en visibilité médiatique.
- Ainsi, en 2017, la conférence des doyens des Facultés de Médecine françaises a adopté une charte rappelant l'importance d'un enseignement qui favorise l'intégrité scientifique et le comportement éthique des futurs médecins.

I. Faire prescrire une nouvelle molécule

A. La publicité
B. La visite médicale
C. La demande des patients

I. Faire prescrire une molécule / C. La demande des patients (1)

- Parfois : demande du patient de disposer de telle ou telle prescription.
- Informés par leur cercle familial ou relationnel plus large ou bien par des moyens mis à disposition depuis plusieurs années par le biais notamment des forums de discussion en ligne.
- Depuis une petite vingtaine d'année on constate un autre vecteur d'information hors du circuit classique des professionnels de santé (principalement autour de la relation médecin-pharmacien-patient) → **forums sur Internet**.
- Madeleine Akrich et Cécile Méadel : nouvel « espace public de la santé » qui permet « une appropriation collective de l'information médicale et la constitution d'une forme d'expertise ».

I. Faire prescrire une molécule / C. La demande des patients (3)

- Critiqués par les professionnels de santé ces outils répondent à une demande des personnes voulant « jouer un rôle plus actif dans la prise en charge de leur santé ».
- **Asymétrie de la relation médecin patient** rend difficile la prise de position d'un patient qui souhaite être acteur de sa santé (paternalisme, etc.), ici ce « différentiel de connaissance » peut être réduit :

  « Le patient est sans doute transformé par ce passage à l'information numérique : celle-ci ne lui fournit pas seulement un accès à l'information plus efficace ou plus large ; elle peut lui permettre à la fois d'acquérir des connaissances de tous ordres (informations scientifiques aussi bien que partages d'expérience), d'élargir ses réseaux sociaux à des « pairs », d'aiguiser sa compréhension des problèmes, sa capacité à poser des questions ; elle lui fournit aussi des occasions de contribuer à la production de connaissances. »

→ « Les forums s'avèrent être un lieu pour « tout dire », sous le couvert de l'anonymat, et pour être entendu, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de la consultation ».

I. Faire prescrire une molécule / Ouverture

- Dans la lignée des critiques de la fin des années 1960 début des années 70
- Critique de la « promotion médicale » par l'industrie
- D'autres moyens d'information notamment pour les professionnels notamment par des revues médicales indépendantes (tel que la Revue *Prescrire*) ou des associations telles que Formindep.



II. Délivrance et usages des médicaments

A. Le rôle primordial des pharmaciens

B. Usages et consommation des médicaments

C. Les rapports individuels au médicament : l'observance, l'automédication

II. Délivrance des médicaments / A. Le rôle primordial des pharmaciens (1)

- Pharmacie = petit commerce + structure de santé
- Pratique de la pharmacie est prise entre les règles de l'activité encadrée et du commerce libre, ainsi qu'en lien avec les statuts du médicament et des autres produits commercialisés (parapharmacie).
- Installation => procédure d'autorisation délivrée par la préfecture en fonction de la couverture des besoins des populations : commerce à part avec une mission de service public.
- Séparation de la prescription et de la fourniture de médicaments : protection du consommateur.
- Le pharmacien titulaire d'officine possède la **double responsabilité** de pharmacien d'officine et de chef d'entreprise :
  - Doit assurer la **dispensation** et le **bon usage** du médicament à usage humain et vétérinaire, il a donc un rôle de **conseil et d'information** du patient et s'assure de la bonne compréhension du traitement par ce dernier. Il intervient également dans la surveillance du médicament – **la pharmacovigilance**. Il joue un rôle majeur dans les **soins de premier recours** (conseil pharmaceutique et/ou orientation vers d'autres professionnels de santé si nécessaire) et participe aux actions de **santé publique, de prévention et de dépistage.**
  - Garantit en toute circonstance un **bon accès au médicament** en gérant les achats, les stocks et la bonne conservation des médicaments ; il gère et manage l'officine et son équipe (pharmaciens adjoints, préparateurs, étudiants, secrétaires…).



II. Délivrance et usages des médicaments

A. Le rôle primordial des pharmaciens

B. Usages et consommation des médicaments

C. Les rapports individuels au médicament : l'observance, l'automédication

II. Délivrance et usages des médicaments / B. Usages et consommation des médicaments (1)

- Le terme « **consommation** » peut regrouper deux pratiques différentes.
  - **Sens économique** (achat du médicament par un consommateur qui peut être un médecin prescripteur, un patient payant lui-même ou un tiers-payant tel que l'assurance-maladie) → contrepartie à la production dans une relation économique.
  - **Registre thérapeutique** : acte de l'application du médicament. Celui-ci est donc pris en forme de comprimé ou de gélule, injecté dans une veine, vaporisé et inhalé ou encore appliqué sur la peau dans un traitement cutané → l'utilisation dans un cadre thérapeutique.

→ différence est toute sauf anodine.

Exemple : augmentation de la consommation des antibiotiques dans un pays sur une période donnée : données fournies par un organisme payant, comme l'assurance-maladie = informent que sur les remboursements d'antibiotiques ≠ médicaments pris.

Le remboursement ne nous renseigne pas sur le volume de médicaments achetés mais stockés voire jetés à la poubelle..

On utilisera **usage** pour qualifier le fait de prendre un médicament



II. Délivrance et usages des médicaments

A. Le rôle primordial des pharmaciens
B. Usages et consommation des médicaments
C. Les rapports individuels au médicament : l'observance, l'automédication

II. Délivrance et usages des médicaments / C. Les rapports individuels au médicament : l'observance, l'automédication (1)

- **Observance** = adéquation des pratiques du patient aux recommandations du médecin, porte, dans le cas des médicaments, sur la posologie (dose, intervalles de prises, durée du traitement) et sur les incompatibilités avec son mode de vie (conduite d'engins ou consommation d'alcool par exemple).
- Objectif : Co: arriver à un comportement du patient considéré comme « rationnel » par le professionnel de santé
- Ne pas imposer un comportement **mais** prendre en compte ses points de vue et ce qui pourrait le pousser à ne pas adopter ce comportement.
- Pensée surtout tous pour les patients avec une maladie chronique.
- Au-delà du conseil médical : prendre en compte l'expertise du malade
- **Information donnée est capitale lors de la prescription**

II. Délivrance et usages des médicaments / C. Les rapports individuels au médicament : l'observance, l'automédication (2)

- Autre aspect important dans le rapport des usagers au médicament : **l'automédication**.
- Lié au risque de **mésusage thérapeutique**.

- **Automédication** : acte de consommer de sa propre initiative un médicament sans consulter un médecin pour le cas concerné, que le médicament soit déjà en sa possession ou qu'on se le procure à cet effet dans une pharmacie ou auprès d'une autre personne.
- Cela concerne donc aussi bien les médicaments prescrits auparavant, les restes de traitements inutilisés et rangés dans sa pharmacie domestique ou obtenus auprès d'un proche que ceux achetés par le patient à son initiative.
- Amalgame fréquent : disponibilité du traitement / innocuité (perçu comme anodin, non dangereux car en vente libre) ex : Paracétamol

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®

A. La création d'une identité de la molécule

B. Usages et usagers

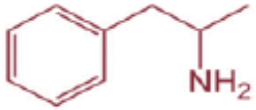
C. La constitution du scandale et les réformes de la régulation

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ A. La création d'une identité de la molécule (1)

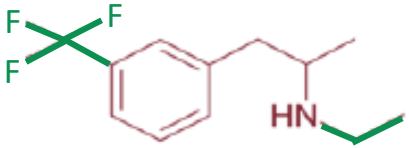
- **Années 1960** : recherches sur les dérivés amphétaminiques et leurs propriétés au sein des Laboratoires Servier.
- Plusieurs molécules sont synthétisées, certaines possèdent des **propriétés anorexigènes** (coupe-faim), telle que la fenfluramine qui est commercialisée en 1968 sous le nom de Pondéral®.
- Synthèse d'un composé, nommé « S992 » au sein du laboratoire. Cette molécule obtient la dénomination commune internationale « benfluorex » en 1971, elle est autorisée en 1974 puis commercialisée sous la marque « Mediator® » à partir de 1976. (**à retenir ici : un composé peut avoir plusieurs dénominations : industrielle, administrative, commerciale**)

→ Sur le marché : fenfluramines = coupe-faim / le Mediator® = traitement des troubles du métabolisme.

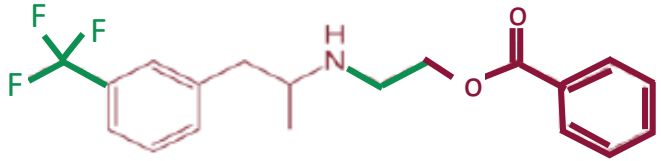
Ne pas apprendre les molécules à titre illustration !!!



Amphétamine



Fenfluramine



Benfluorex

Source : A.Fignolé & S.Lellinger

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ A. La création d'une identité de la molécule (2)

Contexte : L'émergence de la prise de conscience des facteurs des risques cardio-vasculaires associés au surpoids amène les industriels, dont les Laboratoires Servier, à orienter leurs stratégies industrielles et commerciales vers les maladies de l'obésité :

- **« l'approche facteur de risque »** : rôle de certains facteurs favorisant la survenue de maladies cardiovasculaires où l'obésité et les pathologies qui en découlent (diabète, hypertension, hypercholestérolémie) apparaissent comme élément central.
- Nécessité pour les industriels de mettre au point des molécules permettant de traiter ces pathologies, notamment le surpoids. Les propriétés anorexigènes des amphétamines vont ainsi constituer un filon d'or pour les industriels qui vont tenter de synthétiser des molécules tel des **constructions moléculaires (cf. Cours précédent Screening)**.

Epidémiologie : étude de Framingham

=> Idée à retenir : recherche de traitement s'inscrit dans un contexte



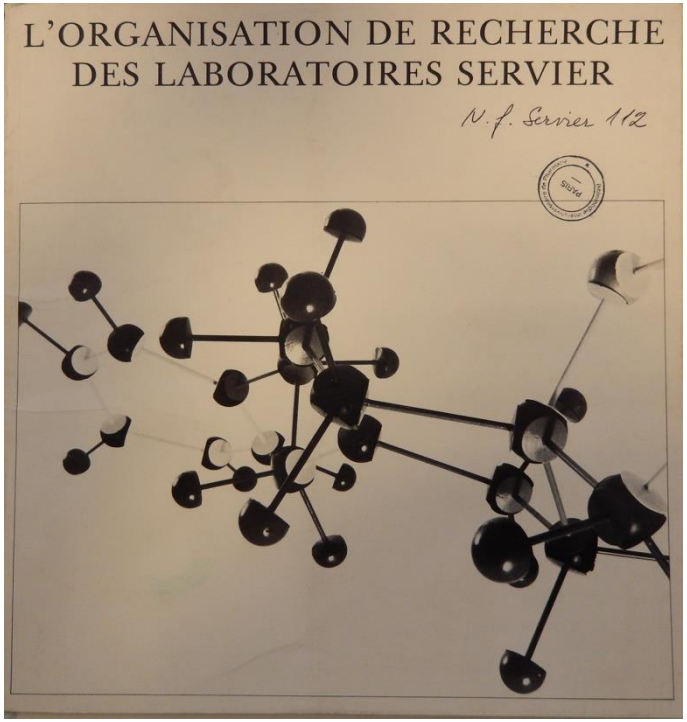
Source image : CHU de Toulouse, *Livret d'information : Les principaux facteurs de risque cardio-vasculaires*, 2015, p.6

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ A. La création d'une identité de la molécule (3)

« Nos sujets de recherche sont choisis, essentiellement, en fonction des nécessités thérapeutiques, et la conception de corps nouveaux se présente à nous comme un devoir.

L'orientation scientifique de notre laboratoire a pour critère l'utilité sociale. Elle s'exerce là où les besoins de la médecine sont et seront, demain, les plus pressants. Chaque fois qu'une série chimique s'avère riche d'applications, c'est sur cette série que nous faisons peser tout le poids de nos investigations ».

Laboratoires Servier 1969



Ici

Utilité sociale perçue par les Laboratoires Servier : traitement des effets du surpoids et positionnement dans l'aire thérapeutique des troubles métaboliques

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ A. La création d'une identité de la molécule (4)

→ **Multiplication des positionnements sur le marché** = différentiation de molécules proches et construction d'une identité marketing

- Benfluorex (Mediator) : le laboratoire investit et de ce fait contribue à légitimer le profil pathologique d'un utilisateur idéaltypique = « polysurchargé » (lien avec la compréhension des maladies par le biais des facteurs de risque en plein essor).
- Dérivés d'amphétamines (fenfluramines) = famille chimique digne d'intérêt : pousse le laboratoire à **développer plusieurs molécules avec des usages proches**, **mais distincts** au sein d'un département de recherche spécifique.

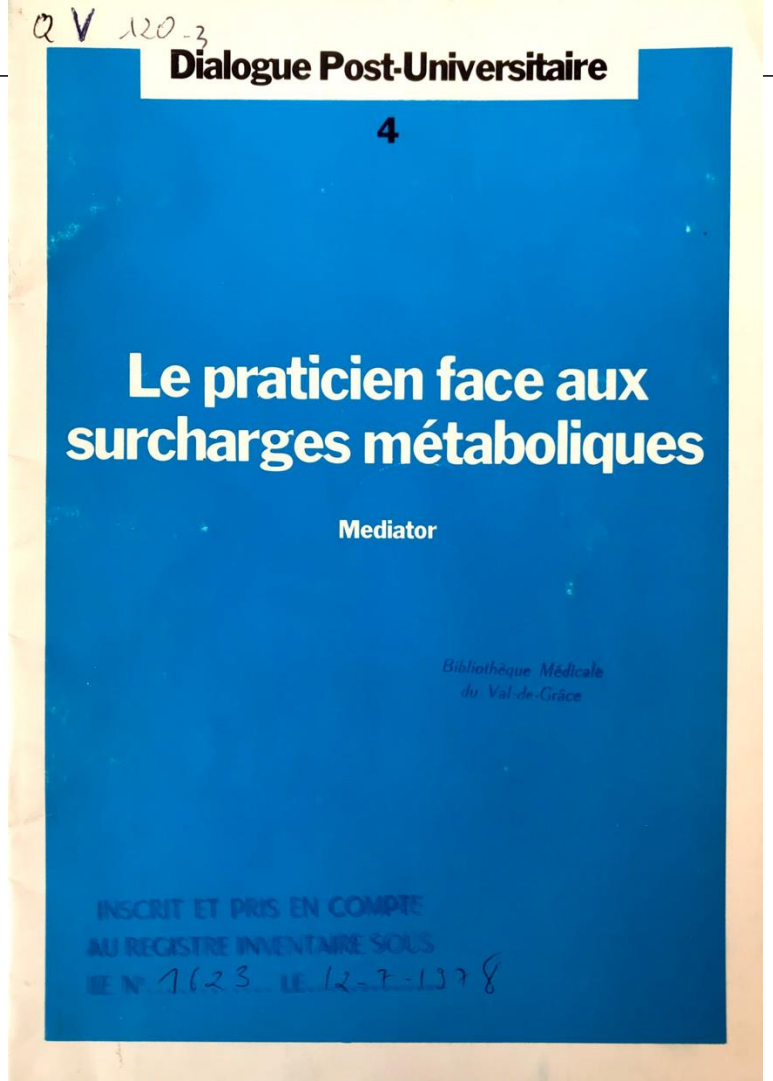
→ Parcours scientifiques commun initialement diverge puis destin régulatoire différent

- Statut et indications des deux molécules (fenfluramine et benfluorex) vont définir par la suite des modalités de prescription et d'usages.

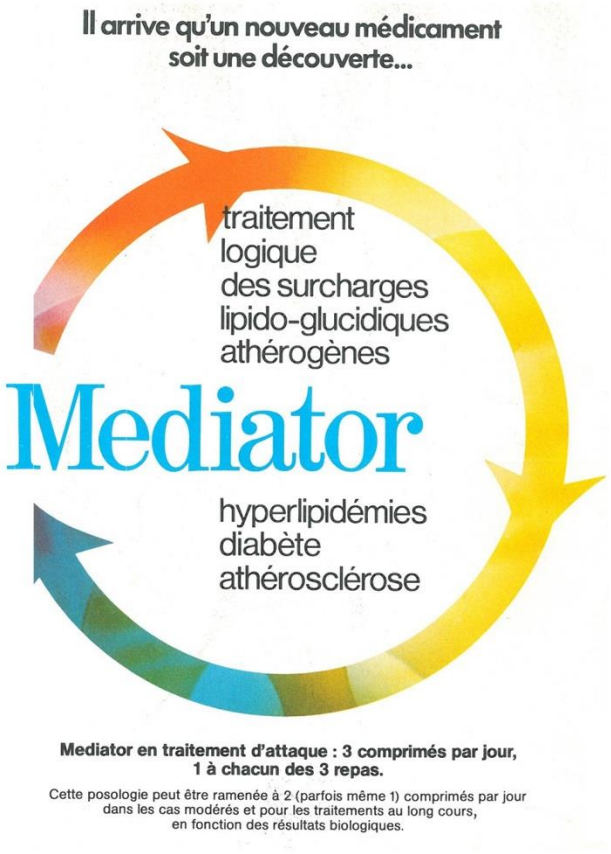
→ La construction de ce profil pathologique, fait exister un besoin thérapeutique auxquels tentent de répondre les laboratoires Servier avec la commercialisation du Mediator®.

- Importance de la publicité





Pour information : commentaires et explications des diapo 36 à 41 disponibles sur la diapo récapitulative 42


Il arrive qu'un nouveau médicament soit une découverte...
traitement logique des surcharges lipido-glucidiques athérogènes
Mediator
hyperlipidémies diabète athérosclérose
Mediator en traitement d'attaque : 3 comprimés par jour, 1 à chacun des 3 repas.
Cette posologie peut être ramenée à 2 (parfois même 1) comprimés par jour dans les cas modérés et pour les traitements au long cours, en fonction des résultats biologiques.



Il est dans
votre salle d'attente

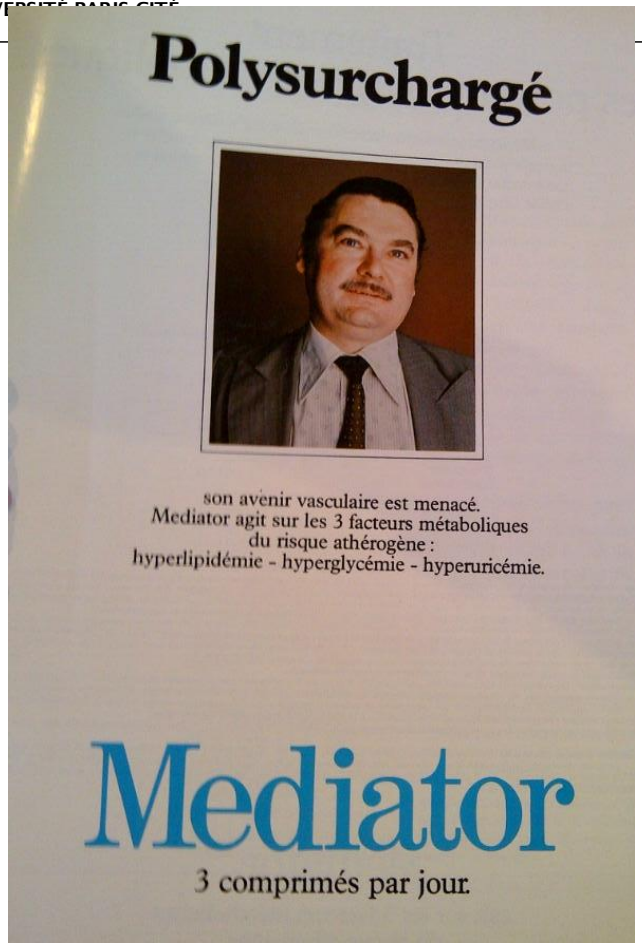


une inquiétude
justifiée

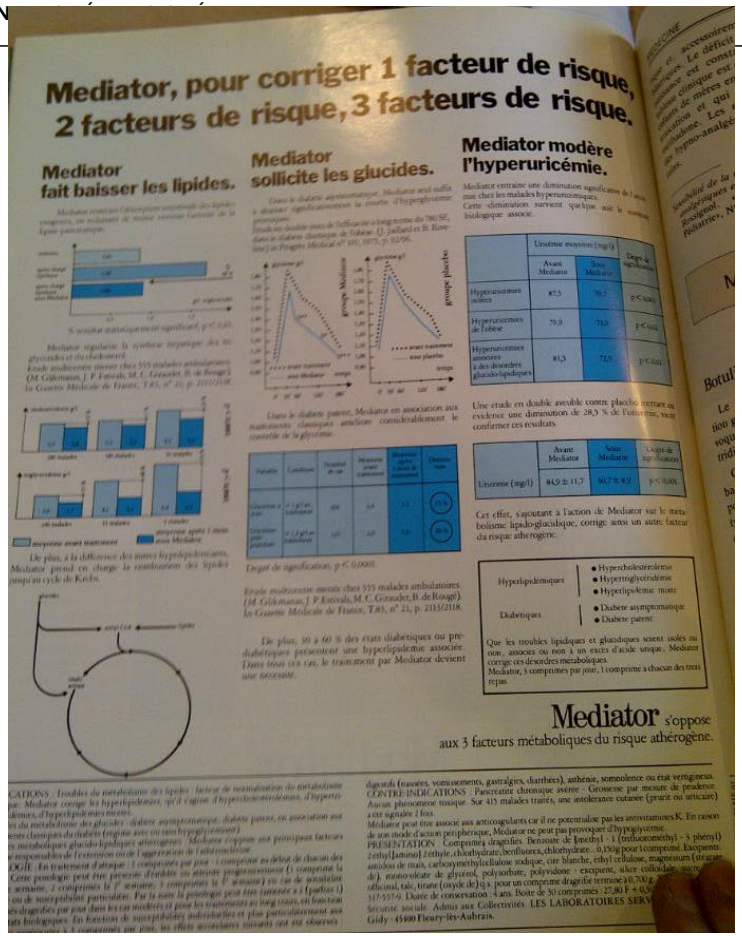


Quand un de vos diabétiques
devient un problème




Polysurchargé
son avenir vasculaire est menacé.
Mediator agit sur les 3 facteurs métaboliques
du risque athérogène :
hyperlipidémie - hyperglycémie - hyperuricémie.
Mediator
3 comprimés par jour.


1x3-2x10-3x35
La probabilité pour un homme de 40 ans de présenter un accident coronarien majeur, est multipliée par 3 s'il existe un facteur de risque, par 10 s'il en existe 2, par 35 s'il en existe 3.
Mediator



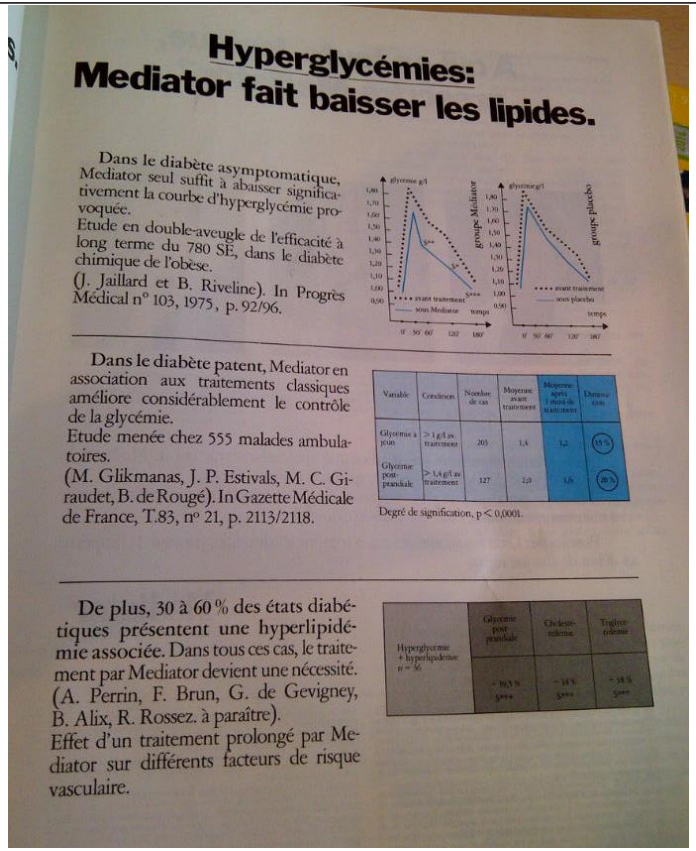
Mediator, pour corriger 1 facteur de risque, 2 facteurs de risque, 3 facteurs de risque.

Mediator fait baisser les lipides.

Mediator sollicite les glucides.

Mediator modère l'hyperuricémie.

Mediator s'oppose aux 3 facteurs métaboliques du risque athérogène.



Hyperglycémies: Mediator fait baisser les lipides.

Dans le diabète asymptomatique, Mediator seul suffit à abaisser significativement la courbe d'hyperglycémie provoquée.
Etude en double-aveugle de l'efficacité à long terme du 780 SE, dans le diabète chimique de l'obèse.
(J. Jaillard et B. Riveline). In Progrès Médical n° 103, 1975, p. 92/96.

Dans le diabète patent, Mediator en association aux traitements classiques améliore considérablement le contrôle de la glycémie.
Etude menée chez 555 malades ambulatoires.
(M. Glikmanas, J. P. Estivals, M. C. Giraudet, B. de Rougé). In Gazette Médicale de France, T.83, n° 21, p. 2113/2118.

Degré de signification, $p < 0{,}0001$.

De plus, 30 à 60 % des états diabétiques présentent une hyperlipidémie associée. Dans tous ces cas, le traitement par Mediator devient une nécessité.
(A. Perrin, F. Brun, G. de Gevigney, B. Alix, R. Rossez. à paraître).
Effet d'un traitement prolongé par Mediator sur différents facteurs de risque vasculaire.





« C'est à vous qu'il appartient maintenant de juger du progrès que représente Médiator, chez vos malades hyperlipidémiques, ou présentant un trouble de la tolérance au glucose, ou déjà athéroscléreux ».

Commentaires et explications diapo 46-41

Diapo 36 L'enjeux principal pour l'industriel est de promouvoir sa molécule afin que celle-ci soit prescrite par les médecins.

- La commercialisation du Mediator® a lieu en septembre 1976, soit deux ans après l'obtention de son autorisation de mise sur le marché. Cette mise sur le marché s'effectue sur fond d'une importante campagne publicitaire destinée aux médecins notamment via de nombreuses brochures et des revues médicales et qui met l'accent sur la nouveauté que représente le Mediator®.
- **Diapo 37** Cette campagne présente le Mediator comme une « découverte » qui est le « traitement logique des surcharges lipido-glucidiques athérogènes » et qui « oriente les lipides vers le cycle de Krebs ».
- C'est l'action du Mediator® sur l'ensemble du métabolisme qui est ainsi mise en avant. La manière dont cet argument a été construit est présentée dans la partie suivante et repose principalement sur le fait que le Mediator® posséderait une action multiple sur les différents troubles métaboliques (diabète, hypercholestérolémie, hyperuricémie). Comme nous l'avons vu, ces différents constituants du syndrome métabolique sont identifiés comme liés aux maladies-cardiovasculaires.
- **Diapo 38** Ainsi, en dehors de cette publicité qui est dans la même lignée que d'autres publicités de l'époque, ce qui distingue le Mediator® est qu'il s'adresse à des patients au profil varié mais tous polypathologiques et qu'il permet ainsi de réduire le nombre de molécules que l'usager doit prendre et évite ainsi la polymédication.
- **Diapo 39-40** : Ces profils de patients, dont certains vont contribuer à forger l'identité du polysurchargé sont mis en regard d'éléments se voulant scientifique, permettant d'argumenter du progrès que représente la molécule, reprenant dans une publicité des codes de publications scientifiques.
- **Diapo 41** D'autres stratégies publicitaires dans la logique d'une démarche de **marketing scientifique** se démarquent des autres publicités que l'on peut observer à l'époque. Par exemple une publicité parue en septembre 1976 qui se présente de prime abord comme une lettre de Jacques Servier s'adressant directement aux médecins, plutôt qu'une publicité reprenant le visuel de la molécule ou de son conditionnement. On peut y lire, en dessous d'une photographie de Jacques Servier et de trois collaborateurs comme pris sur le vif au milieu d'une réunion de travail, que le Mediator® est une véritable découverte, Servier invitant les médecins à « lui consacrer quelques minutes de leur temps » et explique que : « Cette nouvelle molécule se distingue singulièrement par l'originalité de ses effets métaboliques : agissant au carrefour des métabolismes des lipides et des glucides, Médiator peut être considéré comme le premier traitement logique des surcharges lipido-glucidiques athérogènes. Logique, car s'il restreint l'absorption et la synthèse des lipides, il facilite également la pénétration cellulaire du glucose, et oriente ainsi les lipides vers leur combustion énergétique dans le cycle de Krebs, selon l'adage classique : 'les lipides brûlent au feu des glucides'. »

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ A. La création d'une identité de la molécule (12)

Ne pas apprendre !!! => ***Comprendre que l'AMM et les indications ne sont pas figées***

Années	Variation des indications de prescription
1974	– « troubles du métabolisme, troubles métaboliques glucido-lipidiques athérogènes » – « troubles du métabolisme des lipides » – « troubles du métabolisme des glucides »
1979	– « hypercholestérolémies et hypertriglycéridémies endogènes de l'adulte, isolées ou associées, lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant ou lorsque la cholestérolémie après régime reste élevée et/ou qu'il existe des facteurs de risques associés ; la poursuite d'un régime est toujours indispensable » – « adjuvant du régime dans le diabète asymptomatique avec surcharge pondérale »
1987	– « adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies » – *perte de l'indication concernant le diabète, mais ce n'est pas appliqué*
1995	***Interdiction dans les préparations magistrales***
1997	– « adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies » – *retrait de l'indication concernant le diabète*
2001	– « adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies » – « adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale »
2007	– « adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale »
2009	***Retrait***

Utilisateur-type

Utilisateur officiel

NUMÉRO DU DOSSIER :
NL 10008

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Nom du produit : MEDIATOR
Forme : Comprimés Dragéifiés
Nom du Laboratoire : Labo. SERVIER

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

SERVICE CENTRAL DE LA PHARMACIE ET DES MÉDICAMENTS

PH. 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 16 JUIL. 1974

Dossier n° : 10 008

LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Vu le livre V du Code de la Santé Publique (partie législative et partie réglementaire et notamment l'article L 601)

DÉCIDE :

ARTICLE 1er - L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du Code de la Santé Publique est accordée en vue de son débit à titre gratuit ou onéreux à la spécialité :
MEDIATOR, comprimés dragéifiés.
des Laboratoires

Utilisateur cible marketing



Sources : Dossier d'autorisation de mise sur le marché du Mediator® (Annexes IGAS 2-3 et 2-5 (à gauche) ; Publicité du Mediator® dans la revue *Medicographie*, janvier 1980 et brochures publicitaires ~1975 (à droite).

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®

A. La création d'une identité de la molécule

B. Usages et usagers

C. La constitution du scandale et les réformes de la régulation

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ B. Usages et usagers (1)

- Continuité de l'utilisateur type : utilisateur effectif = l'**usager** : passage qui s'effectue par la prescription + délivrance + consommation.

- **Ex du Mediator** illustre bien les **tensions entre identité pharmacologique, identité industrielle et identité administrative**

1. **Demande AMM : faite par un laboratoire pour certaines indications**
2. **Validation par l'autorité administrative sur la base d'un dossier qui mêle aspects scientifiques, techniques et pharmacologiques**
3. **Indications susceptibles d'être réévaluées**
4. **Construction d'un profil pathologique fait exister un besoin thérapeutique auquel le laboratoire tente de répondre**

Ne pas apprendre !!!
Non détaillé en cours

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ B. Usages et usagers (2)

- **Comment avoir des éléments sur les usagers de médicaments ?**
  - Données quantitatives : remboursement
  - Données qualitatives : enquête sociologique

  => Vision partielle
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) : données de remboursement
- Données anonymes concernent les personnes ayant obtenues au moins un remboursement d'une boîte de Mediator® en 2006 soit 303 336 personnes pour lesquelles sont l'âge, le sexe, la répartition géographique sont publiés.
- Sur cette base et celle des données de vente du laboratoire, l'agence du médicament a estimé qu'il y avait eu environ 600 000 personnes qui auraient eu une délivrance de Mediator® entre 2006 et 2009 et 5 millions sur l'ensemble des années de commercialisation de la molécule. Il est important de noter que ces deux éléments sont des estimations.
- Une enquête réalisée auprès des usagers du Mediator® permet d'avoir une approche plus qualitative que les données existantes. Il apparaît que les usagers du Mediator® interrogés sont avant tout des usagères qui au moment de répondre au questionnaire ont entre 45 et 65 ans, vivent en couple, sont domiciliées très majoritairement en zone rurale ou dans des petites villes. Leur niveau d'éducation est plutôt faible. Ces usagers sont majoritairement retraités ou en pré retraite et possèdent majoritairement des revenus inférieurs à 1800€/mois.
- Importance des prescriptions hors indications autorisées dans le cadre de l'AMM pour ses propriétés anorexigènes c'est-à-dire pour perdre du poids. Ce détournement s'amorce à la fin des années 1990 lorsque les autres dérivés d'amphétamines autorisées comme coupe-faim sont retirés du marché français.

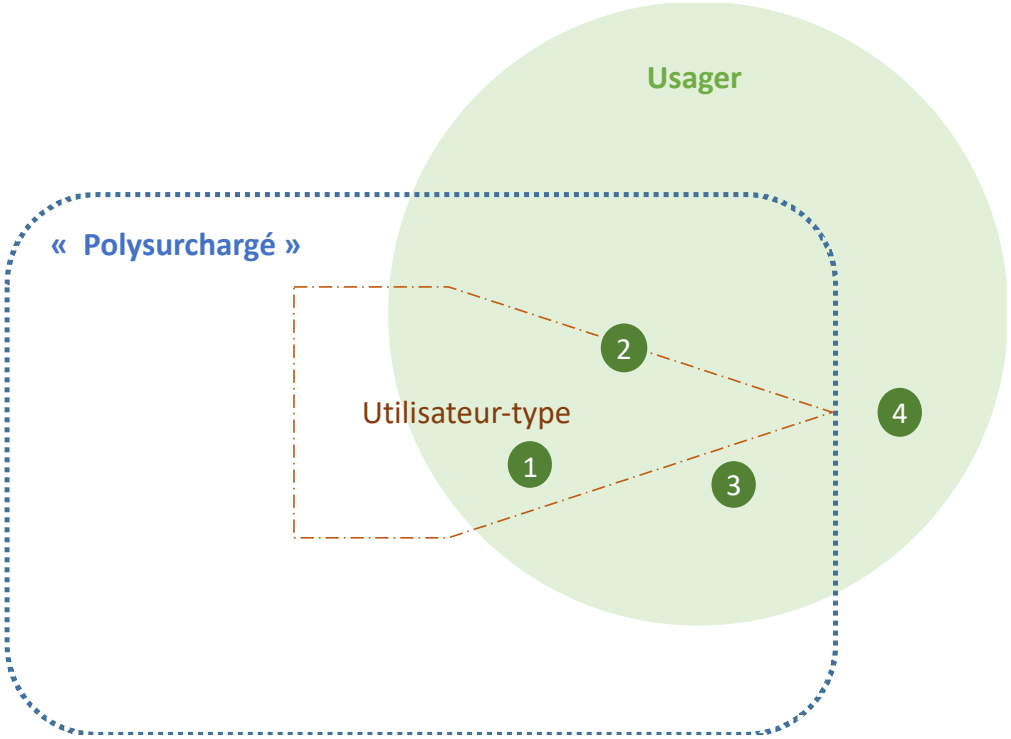
III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ B. Usages et usagers (3)

1.L'usager à la fois utilisateur officiel et cible marketing, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'utilisateur type

2.L'usager devenu uniquement cible marketing, qui en raison des modifications de l'autorisation de mise sur le marché n'entre plus dans la catégorie des utilisateurs officiels (la prescription **devient hors AMM involontaire**)

3.L'usager uniquement cible marketing, qui a pu se voir prescrire le Mediator® sur la base de connaissances historique du médicament qui n'étaient plus à jour de l'AMM (la prescription **est hors AMM involontaire**) ;

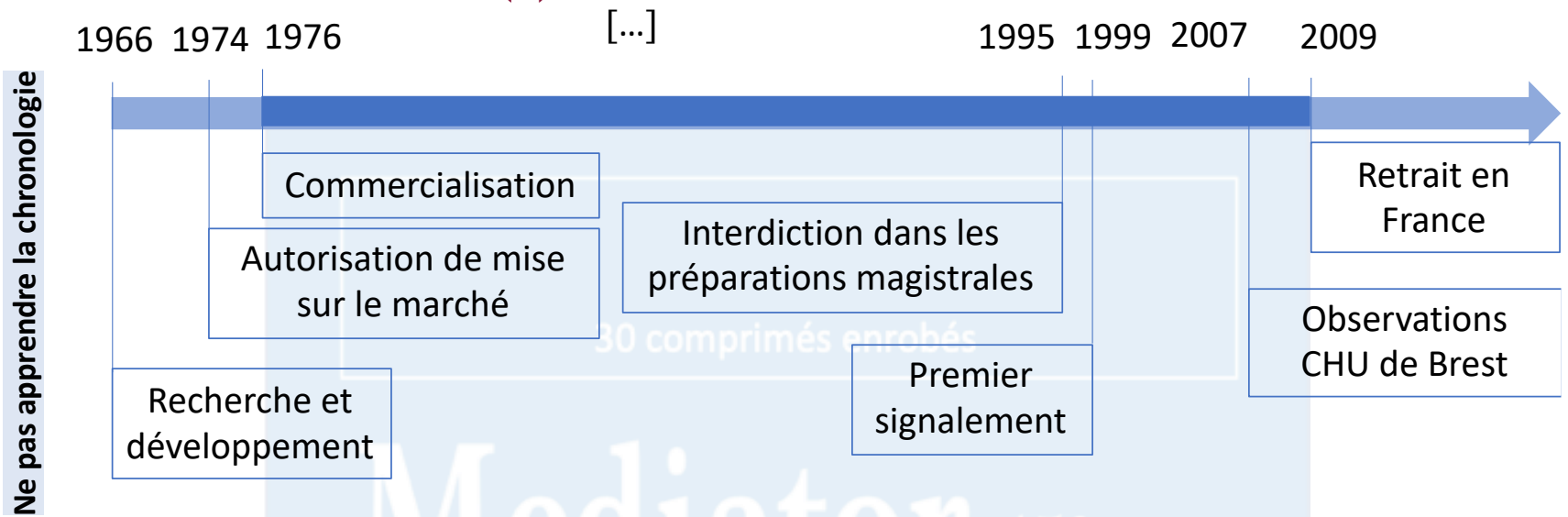
4.L'usager qui ne correspond ni à l'utilisateur-type ni à la cible marketing qui consomme le médicament pour d'autres propriétés que les propriétés officielles (la prescription est **hors AMM volontaire**).



III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®

A. La création d'une identité de la molécule
B. Usages et usagers
C. La constitution du scandale et les réformes de la régulation

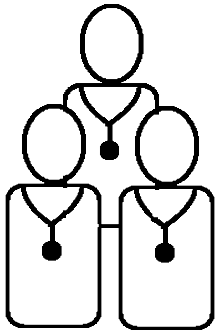
III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ C. La constitution du scandale et les réformes (1)



=> Retenir que le médicament est mis sur le marché dans les années 70, qu'il est sur le marché pendant plus de 30ans avant son retrait, que les signaux d'effets indésirables (pathologies cardio-pulmonaires) sont tardifs

Ne pas apprendre !!!
Non détaillé en cours

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ C. La constitution du scandale et les réformes (2)



Groupe de médecins du CHU de Brest

2007:
Observations (plusieurs cas d'HTAP et un cas de valvulopathie particulière)

Publication des cas en 2009

Mai 2009:
Etude cas-témoins

Octobre 2009 :
Sollicite la CNAM pour réaliser une étude de cohorte

Présentation au comité de pharmacovigilance de l'AFSSAPS

Novembre 2009 :
Reconnaissance de la toxicité du Mediator identification des signes cliniques et retrait de la molécule

=> À retenir : il faut plusieurs études, réalisées sur plusieurs années et plusieurs commissions pour que le médicament soit retiré du marché = difficulté de mettre évidence les effets indésirables

Ne pas apprendre !!!
Non détaillé en cours

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ C. La constitution du scandale et les réformes (3)

Quelques chiffres (**ne pas apprendre ces chiffres**)

- 145 millions de boîtes vendues (300 000/an au moment du retrait)
- Plus de 5 millions de personnes en ont consommé en France
- Rapporte 30 millions d'euros par an au laboratoire

- Novembre 2009 : retrait du médicament

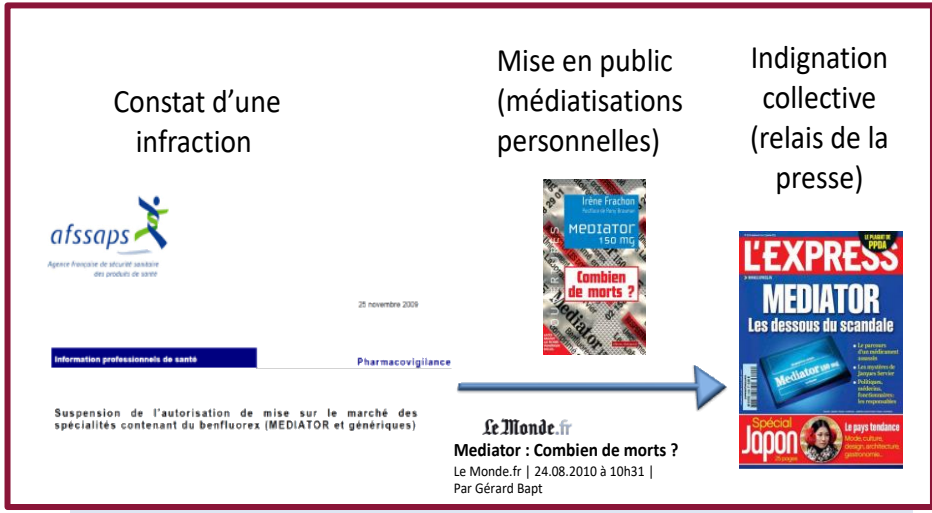
- Juin 2010 : émergence du **scandale sanitaire** :

Def : Une affaire se constitue en scandale lorsqu'une irrégularité constatée est portée dans l'espace public et déclenche une indignation collective. Souvent décrit comme un « dévoilement » il s'agit aussi de fait d'une forme de mobilisation.

Ne pas apprendre !!!
Non détaillé en cours

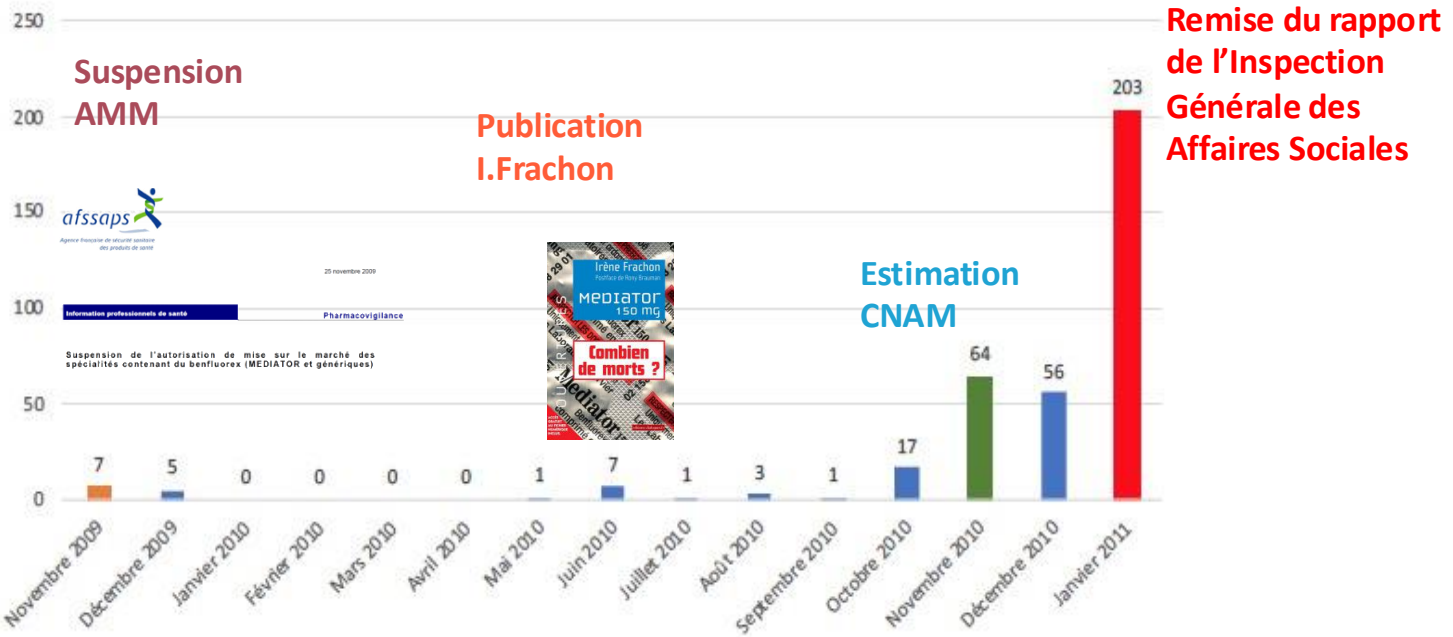
III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ C. La constitution du scandale et les réformes (4)

- Amorce de constitution du scandale du Mediator : livre *Mediator® 150mg : Combien de morts ?* Par Irène Frachon : l'affaire entre dans l'arène médiatique nationale.
- Irène Frachon sort du cadre professionnel et fait ainsi délibérément appel à l'opinion publique.
- Le « **scandale est caractérisé par trois éléments : constat d'une infraction, mise en public et indignation collective** », alors que l'affaire « désigne la période indéterminée entre constat et indignation ».
- Constitution du scandale :premières estimations du nombre de décès.
- Ces estimations sont reprises par le député Gérard Bapt dans un article pour *Le Monde.fr*.
- Publication du rapport de la Cnamts.



« D'après les études réalisées, il semblerait qu'il y ait eu ces dernières années entre 150 et 250 hospitalisations chaque année en France, liées directement à la toxicité du Médiator et ayant entraîné une trentaine de décès. Si nous multiplions par 30 ans de commercialisation, le nombre de morts pourrait être entre 500 et 1000 morts » Flore Michelet

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ C. La constitution du scandale et les réformes (5)

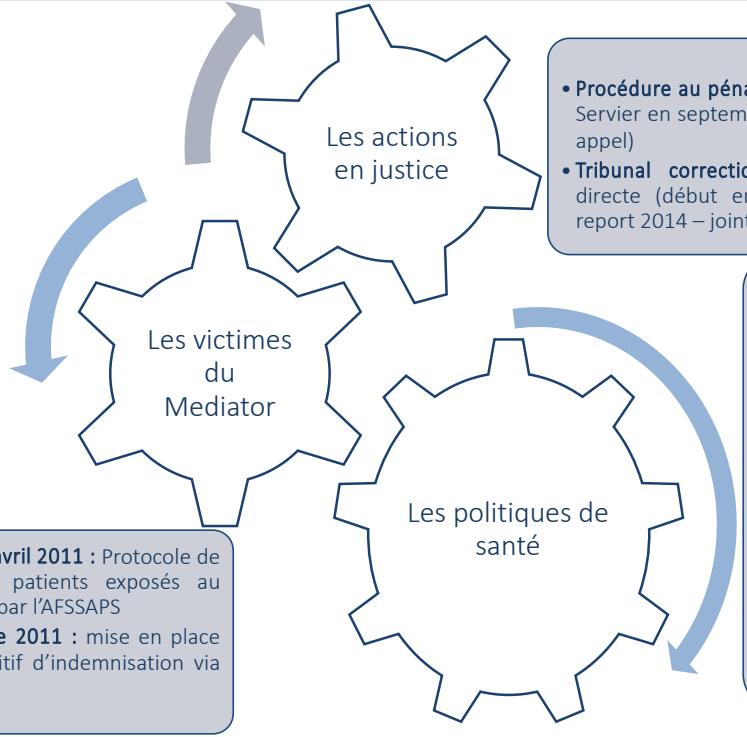


Nombres d'articles consacrés au Mediator® publiés dans la presse française de novembre 2009 à janvier 2011.

Ne pas apprendre !!!
Non détaillé en cours

III. Indications, prescription, usages : l'exemple du Mediator®/ C. La constitution du scandale et les réformes (6)

NE PAS APPRENDRE LE DETAIL : comprendre le mécanisme



- **Procédure au pénal à Paris :** mise en examen de J. Servier en septembre 2011 (jugement mars 2021-appel)
- **Tribunal correctionnel de Nanterre :** citation directe (début en mai 2012, report en 2013, report 2014 – jointe à la procédure parisienne)

- **Janvier – avril 2011 :** Protocole de suivi des patients exposés au Mediator par l'AFSSAPS
- **Septembre 2011 :** mise en place du dispositif d'indemnisation via l'ONIAM

- **Novembre 2010** : Saisie de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) par le Ministre de la santé.
- **Janvier 2011 :** Rapport de l'IGAS
- **Février 2011 :** Assises du médicament
- **Juin 2011 :** Rapports de l'Assemblée Nationale et du Sénat
- **Décembre 2011 :** Nouvelle loi sur le médicament
- **Mai 2012 :** Nouvelle agence (ANSM)

Mise en place d'une nouvelle agence = réponse politique à la crise

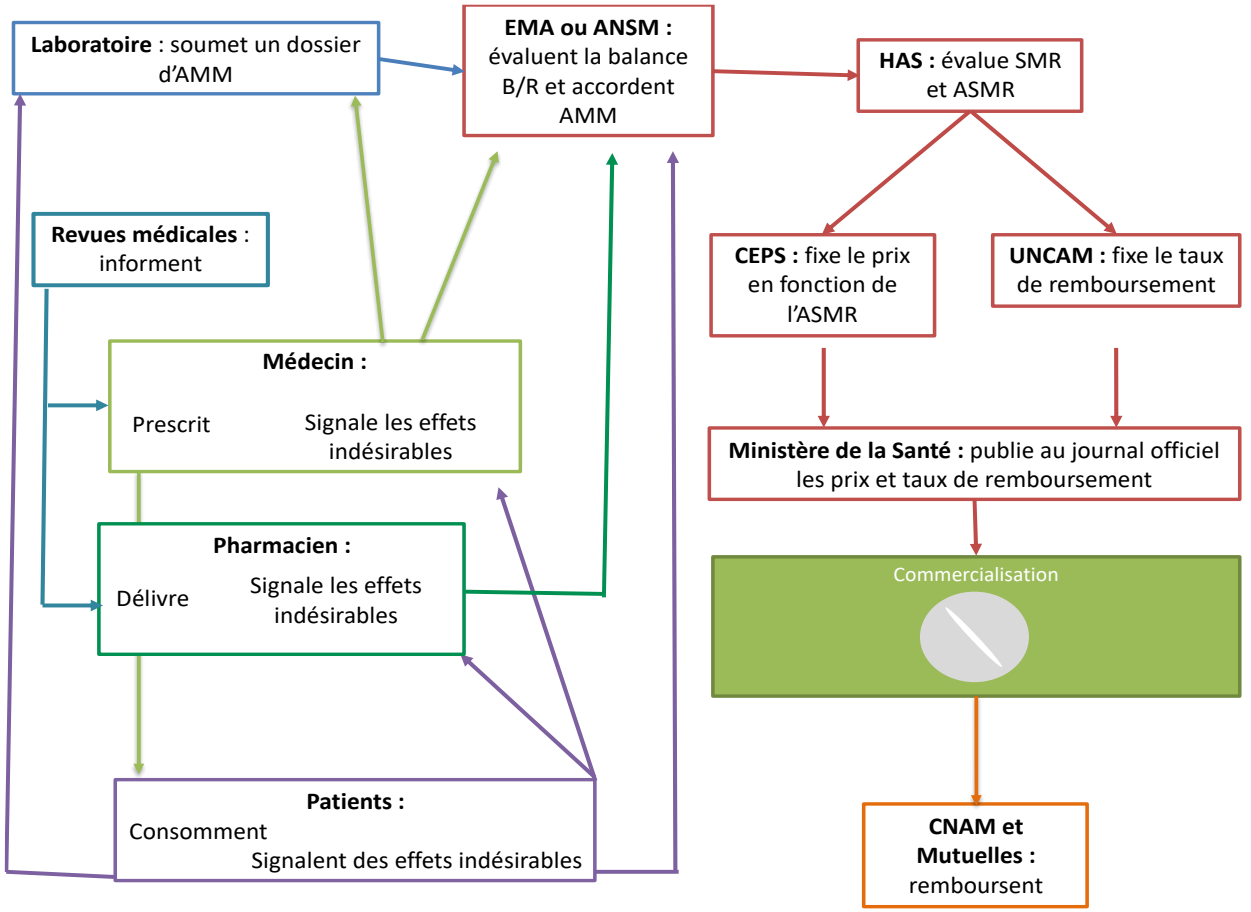
Solutions proposées :

- Gestion des conflits d'intérêts
- Redéfinition des différentes phases (mise sur le marché, prescription, délivrance, pharmacovigilance,etc)

- Visibilité dans l'espace médiatique pour les victimes de médicament.

Conclusion

- Objet complexe faisant intervenir de nombreux acteurs aux intérêts divers
- Au cœur des interaction médicale
- Importance de l'information sur le médicament
- Nécessité de surveillance : risque inhérent au médicament



Bibliographie (indicative)

BONAH Christian, « Professional, industrial, and juridical regulation of drugs : the 1953 Stalinon case and pharmaceutical reform in postwar France » dans Jean-Paul Gaudillière et Volker Hess (eds.), *Ways of regulating drugs in the 19th and 20th centuries*, Houndmills Basingstoke, Palgrave MacMillan (coll. « Science, technology and medicine in modern history »), 2013, p. 245-269.

BONAH Christian, « L'affaire du Stalinon : et ses conséquences réglementaires, 1954-1959 "Sécurité sanitaire" et innovation thérapeutique en France il y a 50 ans. », *La Revue du praticien*, 2007, vol. 57, nº 13, p. 1501-1505.

BONAH Christian et RASMUSSEN Anne, *Histoire et médicament aux XIXe et XXe siècles*, Paris, Éditions Glyphe (coll. « Société, histoire et médecine »), 2005, 273 p.

CHAUVEAU Sophie, « Genèse de la « sécurité sanitaire »: les produits pharmaceutiques en France aux XIXe et XXe siècles », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 2004, vol. 51-2, nº 2, p. 88.

CHAUVEAU Sophie, *L'invention pharmaceutique : la pharmacie française entre l'État et la société au XXe siècle*, Paris, Institut Synthélabo (coll. « Les Empêcheurs de Penser en Rond »), 1999.

CHAUVEAU Sophie, « Entreprises et marchés du médicament en Europe occidentale des années 1880 à la fin des années 1960 », *Histoire, économie et société*, 1998, vol. 17, nº 1, p. 49-81.

GAUDILLIÈRE Jean-Paul, *La médecine et les sciences XIXe-XXe siècles*, Paris, La Découverte (coll. « Repères (Maspero), ISSN 0993-7625 ; 465 »), 2006, vol. 1/, 121 p.

GAUDILLIÈRE Jean-Paul, *Inventer la biomédecine: la France, l'Amérique et la production des savoirs du vivant, 1945-1965*, Paris, La Découverte (coll. « Textes à l'appui »), 2002, 391 p.

GAUDILLIÈRE Jean-Paul et ZIMMER Alexis, « Essais cliniques et "médecine des preuves" » dans Christian Bonah, Claudie Haxaire, Jean-Marc Mouillie, Anne-Laurence Penchaud et Laurent Visier (eds.), *Médecine, santé et sciences humaines. Manuel du Collège des enseignants de SHS en médecine et santé.*, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 577.

MARKS Harry, « Making the risk visible: The science, politics, and regulation of Adverse Drug Reactions » dans Jean-Paul Gaudillière et Volker Hess (eds.), *Ways of regulating drugs in the 19th and 20th centuries*, Houndmills Basingstoke, Palgrave MacMillan (coll. « Science, technology and medicine in modern history »), 2013, p. 97-120.

MARKS Harry, « Confiance et méfiance dans le marché : les statistiques et la recherche clinique (1945-1960) », *Sciences sociales et santé*, 2000, vol. 18, nº 4, p. 9-27.

MARKS Harry, *La médecine des preuves : histoire et anthropologie des essais cliniques : 1900-1990*, traduit par Françoise Bouillot, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance (coll. « Les Empêcheurs de penser en rond »), 1999, 352 p.